סמים, הרעלות ומינון יתר

עמוד 1: רעל וגישה כללית · אלכוהול ומתנול · זרחנים אורגניים

דף סיכום · פודקאסטים קלוד


פרצלסוס: רק המינון הוא הרעל

רעל, גמילה והגישה בשטח

מהו רעל?

רק המינון הוא הרעל (פרצלסוס): כל חומר, אפילו מים וחמצן. **הרעלה:** הגוף קיבל מספיק כדי שיופיעו סימנים מסוכנים ולא רצויים. **טוקסידרום:** התמונה האופיינית לחומר. רוב ההרעלות אינן מסמים: תרופות, חומרי ניקוי, בכוונה או בטעות.

תסמונת גמילה

הסימנים **הפוכים לסימני החומר**: ממריץ ← דיכוי, מדכא ← עוררות. תלות נפשית: קרייבינג. לרוב לא מסכנת חיים מיד, אבל לפעמים מסכנת את המטפל. חריג: **דליריום טרמנס**. נותנים נרקן? צפה לגמילה והיערך.

הגישה למכור

התמכרות היא מחלה, ורבים התחילו מתרופות חוקיות. בלי שיפוט ובלי כינויי גנאי. רצון אובדני ← ברצינות; רוצה להיגמל ← הפניה דרך צוות המלר"ד. רוב המכורים אינם אלימים.

הגישה להרעלה

ABC וטיפול תומך · איתור החומר (**זהירות ממחטים**) · התאמה לטוקסידרום · **לשלול היפוגליקמיה, היפותרמיה וטראומה** · סקירת מערכות, ניטור, היסטוריה כולל שלילת אובדנות.

בזירה: ריחות (פירות רקובים, אלכוהול, טינר וצבע, שקדים: ציאניד) · לצלם או לקחת את האריזות · סימנים שסותרים את הסיפור.

שימו לב: לא מעודדים הקאה, **לא** משלשלים, **לא** מאלתרים אנטידוט. מוקד ההרעלות: רק דרך המוקד הרפואי, בשיחה מוקלטת.

אנטידוטים

נרקן ← אופיאטים (הכלי שלנו בשטח) · פלומזניל ← בנזודיאזפינים · אצטילציסטאין ← אקמול · גלוקגון ← חומסי בטא · ויטמין K ← קומדין · פרוטמין ← הפרין · דיגיבינד ← דיגוקסין · הידרוקסוקובלמין ← ציאניד · **ביקרבונט** ← טריציקליים (יש בניידת) · סידן ← חומסי תעלות סידן. **בבי"ח:** טיפול תומך, הבססת שתן, פחם פעיל, שטיפת קיבה (רק עד כחצי שעה), דיאליזה.

אלכוהול ומתנול

איך הוא פועל?

מעל 0.2% אתנול = סם חוקי, שהורג יותר מכל סם אחר. מגביר עיכוב בקולטני GABA ← **סם מדכא**: שיפוט, הכרה, קואורדינציה, זמן תגובה. מרחיב כלי דם, מוריד דופק ול"ד. מדכא ADH ← השתנה, התייבשות. **חמרמורת:** התייבשות וסוכר נמוך ← **סוכר לכל מטופל ששתה.**

שתייה כרונית

דלקת לבלב, שחמת, דליות בוושט, נטייה לדימומים, מאלורי וייס. בשטח: **לשלול היפוגליקמיה והיפותרמיה.**

גמילה מאלכוהול

שעות עד כ-7 ימים: עצבנות, רעד, טכיקרדיה, הזעה, יל"ד ← הזיות, פרכוסים ← **דליריום טרמנס** (שינויים תכופים בהכרה; ספר הקורס: יממה עד יומיים, מצגת ההרעלות: יומיים עד שלושה; בלי טיפול תמותה עד 50%). ABC, נוזלים, גלוקוז · **שקול דורמיקום** ☎ **באישור מוקד** · בבי"ח תיאמין.

שימו לב: מתנול (אלכוהול מזויף, נוזל שמשות): עיוורון, פגיעה בלב ובכליות, מוות מחמצת. בבי"ח: אתנול, פומפיזול, דיאליזה.

זרחנים אורגניים

מה הם עושים?

חוסמים את **אצטילכולין אסטרז** ← עודף אצטילכולין ← פעילות יתר פרה-סימפתטית. נספגים דרך העור. חומרי הדברה, תרופות, גז עצבים; עובדי חקלאות וילדים.

המטופל המתכווץ ונוזל: אישונים מכווצים, ריור, הזעה, ברדיקרדיה ושוק, פרכוסים. מתים מכשל נשימתי ומהפרעות קצב (QT ארוך, טורסד).

מד"א: זרחנים אורגניים (אוגדן עמ' 147)

1. **שמור** על בטיחות · **פעל** לפי גישה כללית · **הערך** את החומרה
2. **קל: נטר** מדדים · **שקול** אטרופין ☎
3. **בינוני: תן** אטרופין 2–1 mg IV · **תן** אירובנט 1 mg · אין שיפור ← **שקול** מנות חוזרות ☎
4. **קשה (בלי ☎): תן** מנות חוזרות 4–2 mg · מכפילים כל 5 דק' · אין מינון מרבי · **תן** אירובנט · **שקול** דופמין, נתיב אוויר מתקדם, דורמיקום
5. **המשך** ניטור וטיפול בפינוי דחוף · **שקול** דיווח מקדים

אטרופיניזציה: ההזעה נפסקת, ההפרשות נעצרות, דופק מעל 80. פינוי ממושך: הזלפה, 20% מהכמות לשעה.

מקור: התסריטים של הסדרה (מצגת הקורס והאוגדן). הדף חומר לימוד ואינו מהווה תחליף לפרוטוקול מד"א המעודכן. איורים: מקוריים, בסגנון הסרטון. דיוקן פרצלסוס, רובנס (מעובד): Sailko, CC BY 3.0, ויקישיתוף.

סמים, הרעלות ומינון יתר

עמוד 2: סמים פסיכואקטיביים · אופיואידים ונרקן · ממריצים ומעוותי תודעה

דף סיכום · פודקאסטים קלוד


צמח הפרג: מקור האופיום

סוגי סמים ואופיואידים

שלוש קבוצות

מדכאים: אופיום, תרופות שינה, הרדמה · **ממריצים:** קוקאין, אמפטמינים, גת, ריטלין · **משני תודעה:** LSD, פטריות, צמחים. נטילה: הסנפה, הרחה חמה, בליעה, ריריות, וריד, שאיפה. לא כל חשיפה פלילית.

אופיואידים

אופיום מהפרג · **פנטניל** פי 100–50 ממורפין (גם מדבקות) · טרמדול, קודאין, אוקסיקודון · **הרואין:** אבקה חומה-בז'; "המשתמש החוזר": מנת יתר קטלנית; וירידים פגועים, HIV והפטיטיס · **אדולן (מתדון):** תחליף, כחלחל, בשתייה.

הכלל: ברדיפניאה + אישוני סיכה = אופיאטים עד שהוכח אחרת.
גם: דיכוי שיעול, ל"ד ודופק יורדים, ירידה בהכרה, סימני הזרקה. אישונים תקינים **לא שוללים**.

לפני הנרקן: קודם **מנשימים** (חמצן ואמבו). האינדיקציה: **דיכוי נשימתי**, לא חוסר הכרה. המטרה: אוורור, לא התעוררות; עוצרים באפקט הרצוי. נרקן פועל עד כ-20 דק' ← ניטור רציף. מינון גבוה ← גמילה פתאומית, פרכוסים.

מד"א: שינויים במצב ההכרה (אוגדן עמ' 86)

1. גישה כללית · **אבטח** נתיב אוויר · **השכב** על הצד · **שקול** חמצן (סטורציה מעל 92%)
2. **התקן** עירוי IV/IO · **בצע** תשאול ובדיקה · **בדוק** סוכר (היפוגליקמיה: ענף נפרד)
3. חשד לאופיאטים ← **תן** נרקן IV/IN/IO (חובה, בלי ☎) · חזרה: לוורידכל 3–5 דק', באף אחרי 5–10 דק'
4. אין שיפור ← **שקול** נתיב אוויר מתקדם · **חפש** גורמים אחרים · **המשך** ניטור בפינוי דחוף · **בצע** מדדים כל 5–10 דק' · **שקול** דיווח מקדים

0.4–2 mg	2 mg	10 mg
לוריד: מהול ב-10 ml, איטי	דרך האף: במנות של 0.4	מקסימום מצטבר

ממריצים, מעוותי תודעה וסמים חדשים

אופיואידים	ממריצים
נשימה מדוכאת · ברדיקרדיה · ל"ד יורד · היפותרמיה · אישוני סיכה	טכיפניאה · טכיקרדיה · ל"ד וחום גבוהים · אישונים מורחבים

קוקאין ואמפטמינים

קוקאין: **הלב** (כאב בחזה, הפרעות קצב, עווית כליליים, אוטם). **אין מינון בטוח**, גם בפעם הראשונה. אמפטמינים, ריטלין וגת: חום, פסיכוזה, חריקת שיניים, ו"דאון" של ימים.

שימו לב: MDMA: מכת חום, ושתיית מים ← **היפונתרמיה**, בצקת מוחית. צעיר ממסיבה, חם, מבולבל או מפרכס: לחשוב על שניהם.

עוד ממריצים

דוסה (הקאות, פסיכוזה), דוקטור (6–4 שעות). **קפאין** מעל 250 mg: עוררות יתר וסכנת הפרעות קצב.

מעוותי תודעה

LSD: עיוותי ראייה ושמיעה, טריגר לפסיכוזה. פטריות: תסמונת סרוטונין. **קטמין:** ניתוק, "קיי הול", נזק לשלפוחית.

קנאביס וסמים חדשים

עיניים אדומות, תיאבון, פה יבש; טכיקרדיה, חרדה, פרנויה. **קנבינואידים סינתטיים** (נייס גאי): חזקים עד פי 800, יל"ד, פסיכוזה; **בדיקת THC שלילית לא שוללת**. **GHB:** סדציה ואמנזיה ← משטרה ובי"ח עם חדר 4; בשתן רק עד כ-12 שעות.

מד"א: מטופל אגיטטיבי (אוגדן עמ' 88)

1. **שמור** על בטיחות (אלים ← מרחק ומשטרה) · גישה כללית
2. סיבה נפשית ← הפרוטוקול המתאים · לא ← **נסה** להרגיע, **שקול** חמצן
3. אי אפשר להמשיך ← **שקול** הגבלה פיזית · **שקול** סדציה ☎
4. **בצע** אבחנה מבדלת (גם אלכוהול וסמים) · **פנה** בדחיפות

3 דברים לזכור

1. **בכל הרעלה: ABC, איתור החומר, ושלילת היפוגליקמיה, היפותרמיה וטראומה**
2. **זרחנים: אטרופין עד ייבוש ההפרשות. בינוני 1–2 mg · קשה 2–4 mg · מכפילים כל 5 דק'**
3. **ברדיפניאה ואישוני סיכה: קודם מנשימים, ורק אז נרקן. לוריד 0.4–2 mg · עד 10 mg**

מקור: התסריטים של הסדרה (מצגת הקורס והאוגדן). הדף חומר לימוד ואינו מהווה תחליף לפרוטוקול מד"א המעודכן. איורים: מקוריים, בסגנון הסרטון. צמח הפרג (מעובד): George Chernilevsky, CC BY-SA 4.0, ויקישיתוף.